

1. בן 46, מתלונן על עייפות בשעות היממה. מה מבין הבאים מהווה קריטריון לאבחנת תסמונת דום נשימה בשינה (Obstructive Sleep Apnea)?
- א. עדות של בן/בת הזוג על היקף נחירות ויקיצות בשעות השינה.
ב. בבדיקת שינה מספר הפסקות הנשימה החלקיות והמוחלטות הוא מעל 15 בשעה
ג. שיפור באיכות השינה לאחר ניסיון טיפולי במכשיר CPAP
ד. העדר ירידת לחץ הדם בשעות השינה בבדיקת הולטר בשעות השינה.
2. אילו מהמצבים הבאים יחשיד כי המטופל סובל מ-Glaucoma (ברקית)?
- א. לחץ תוך עיני 16 מ"מ כספית בשתי העיניים.
ב. פגיעה בשדות ראייה היקפיים
ג. בבדיקת עובי הקרנית, הקרנית נמצאה מעובה.
ד. יחס Cup/Disc בבדיקת פונדוס יהיה נמוך.
3. בת 72, מטופלת בתרופות רבות למחלת לב איסכמית, סוכרת, כאבי ברכיים, ותכיפות בהטלת השתן. את/ה שוקל לרשום לה טיפול ב-Elatrol (Amitryptiline) עקב פיברומיאלגיה. מאיזה שילוב תרופתי יש להיזהר עקב תופעות לוואי משותפות?
- א. Carvedilol (Cardiloc)
ב. Metformin (Glucophage)
ג. Acetaminophen (Paracetamol)
ד. Tolterodine (Detrusitol)
4. באיזה מהאוכלוסיות הבאות ניתן להשתמש ב-HbA1c כבדיקה לאבחנת סוכרת?
- א. Sick Cell Disease
ב. הריון בטרימסטר ראשון
ג. חולה דיאליזה עם טיפול באריטרופואטין
ד. בן 15 הסובל מפוליאוריה ופולידיפסיה.

5. אצל איזה מטופל יש לחשוד בהתפתחות קטרקט?
- א. בן 75, מתלונן על ירידה בראייה, תחושת סינוור, ובנוסף – "הילה" סביב עצמים.
- ב. בן 80, מתלונן על קושי בראיית לילה, וטשטוש בשדה ראייה מרכזי.
- ג. בן 50, סכרת סוג 1, מציין ירידה בראייה, רואה דברים צפים בשדה הראייה.
- ד. בן 60, ללא תלונות. בבדיקה שגרתית התגלה איבוד ראייה פריפרי במידה קלה.
6. למי מהבאים תמליצו על חיסון ZOSTAVAX למניעת שלבקת חוגרת?
- א. בת 68, עברה לפני 3 שנים השתלת מח עצם
- ב. בן 70, מטופל עם פרדניזון 60 מ"ג ליום עקב COPD קשה
- ג. בת 48, חלתה לפני שנה בשלבקת חוגרת
- ד. בת 40, בהריון ראשון שנחשפה לחולה אבעבועות רוח
7. בת 42 בריאה בדרך כלל, מבצעת פעילות ספורטיבית סדירה ולא נוטלת תרופות. לאחרונה מודדת לחצי דם, במספר פעמים נמדדו ערכים של 160/90. בדיקה גופנית תקינה.
- במעבדה - קראטינין 0.6, אוראה-20, אשלגן-3.2 נתרן-142
- מהי הבדיקה שתאשר את האבחנה הסבירה למצב זה?
- א. 24 hour metanephrines
- ב. Aldosterone and renin levels
- ג. Short Dexamethasone test
- ד. Renal artery doppler
8. בן 6 חודשים מגיע עם אביו, המספר על נפיחות בשק האשכים.
- מה ההמלצות הטיפוליות בחשד לבקע מפשעתי?
- א. לבצע תיקון בקע בהקדם
- ב. לבצע תיקון במידה ולא ייסגר ספונטנית עד גיל 5 שנים.
- ג. בכל ניתוח יש לבצע אקספלורציה של שתי המפשעות.
- ד. בהיותו זכר מומלצת אקספלורציה דו צדדית עקב סיכון מוגבר לבקע דו צדדי.

9. בן 10, בחודשים האחרונים אירועים חוזרים של כאבי ראש. לפני הכאב מתאר הבזקים בראיה. הכאב נמשך מספר שעות, בד"כ מבקש להיכנס לחדר חשוך ולנוח עד שכאב יחלוף. אין סיפור משפחתי של מיגרנה. בדיקה גופנית ונורולוגית תקינה
מה יש לעשות בכדי להתקדם באבחנה?

א. בדיקת EEG

ב. הדמיה מוחית

ג. בדיקות דם

ד. בדיקת LP

10. בת 23, בריאה בד"כ. מתלוננת על כאב בטן תחתונה ודימום וגינלי. וסת אחרונה לפני 6 שבועות. בדיקה ביתית להריון חיובית. בבדיקת סונר וגינלית לא הודגם שק הריוני.
מהו הצעד הבא?

א. לפרוסקופיה בשאלה של הריון אקטופי

ב. סונר וגינלי חוזר בעוד שבוע ימים

ג. בדיקה כמותית ל- bHCG בסרום .

ד. מעקב בלבד ולהמתין לווסת הבאה.

11. בן 52, בריא בד"כ, נוסע לחו"ל בתדירות גבוהה. שואל איך להימנע מ-DVT.
מהי ההמלצה עבור מטופל זה?

א. הליכה כל כשעה במטוס גם בטיסות קצרות מ- 4 שעות

ב. שתיה לרוויה לפני הטיסה ובתדירות גבוהה במהלך הטיסה.

ג. מתן tab. Acetosal (Acetylsalicylic Acid) במינון 300 מ"ג שעה לפני הטיסה

ד. זריקת Clexane (Enoxaparin) במינון 40 מ"ג שעתיים לפני הטיסה.

12. לפניך תיאור של ארבעה חולים שאובחנו עם בעיה נפשית ומסרבים לקבל טיפול נפשי. כלפי מי מהמטופלים יהיה צורך להפעיל חוק לצורך בדיקה בכפיה כעת?
- א. בן 19, מסתגר בחדרו, יוצא לאכול לבדו למטבח ולא אוכל עם משפחתו כי טוען שמנסים להרעיל אותו. כאשר אמו מנסה להיכנס לחדרו נועל את החדר וצועק עליה.
- ב. בת 40, לוקה בסכיזופרניה וסכרת תלוית אינסולין. לאחרונה הפסיקה גם טיפול פסיכיאטרי וגם אינסולין בטענה שקריין בטלוויזיה הורה לה להפסיק את הטיפול. הגיעה עם DIABETIC FOOT.
- ג. בן 45, סובל מ-PTSD, לעיתים קרובות מתעצבן ואז מרביץ לאשתו ומאיים שיהרוג אותה.
- ד. בן 65 אובחן כלוקה ב-ALS. מאז האבחנה שוכב במיטה, מסרב לפגוש את המשפחה, מסרב לאכול ולשתות.
13. בת 32, ברקע - תסמונת המעי הרגיש (IBS). מזה 3 חודשים סובלת מכאב באזור Supra pubic ובנוסף צריבה ותכיפות במתן שתן, וכאב בקיום יחסי מין. בבדיקתה – רגישות במישוש Supra pubic.
- מה יאפיין בדיקת שתן במטופל זאת?
- א. בדיקה תקינה
- ב. מיקרומטוריה
- ג. ניטריטים חיוביים וללא לויקוציטים
- ד. צמיחת Chlamydia
14. מהו השיקול בהמלצה לגבי טיפול מונע להתפתחות סוכרת מסוג 2?
- א. Metformin הוכח כטיפול היעיל ביותר למניעת התפתחות סוכרת.
- ב. Metformin יעיל בכל קבוצות הגיל בפרט בגברים בבני 60 ומעלה עם עודף משקל.
- ג. מומלץ להימנע משימוש ב-Metformin כמניעה בנשים בגיל פוריות.
- ד. פעילות גופנית סדירה יעילה לפחות כמו מטפורמין במניעת התפתחות סוכרת.
15. בן 15, סובל מאקנה בדרגה קלה.
- מה הטיפול המומלץ?
- א. Roaccutane (Isotretinoin) פומי
- ב. Minocycline פומי
- ג. משחת (Erythromycin) Acnetrim
- ד. משחת (Benzoyl peroxide+Clindamycin) Duac

16. בת 47, מזה 3 חודשים סובלת מכאבים באזור מפרק הירך משמאל ובאספקט לטרלי של הירך. בבדיקתה - רגישות למישוש באזור הטרוכנטר, כאב בזמן רוטציה פנימית, ללא הגבלה בטווח תנועה.

מה גורם סיכון למצב זה?

א. שימוש ממושך בסטרואידים

ב. סוכרת

ג. אלכוהוליזם

ד. ריצות שטח

17. בן 50, BMI=37, מתלונן על נפיחות ברגליים. בבדיקתו בצקות גומתיות בכפות הרגליים עד גובה השוק. שאר בדיקה גופנית תקינה. בדיקות המעבדה וצילום חזה תקינים. באקו לב יתר לחץ דם ריאטי.

מה השלב הבא בבירור?

א. CT חזה

ב. בדיקה במעבדת שינה

ג. בדיקת תפקודי נשימה

ד. US דופלר לורידי הגפיים

18. מה נכון בטיפול באי ספיקת לב עם מקטע פליטה (EJECTION FRACTION) ירוד?

א. יש להפסיק טיפול בחסמי בטא מכיוון שיכול להעלות תמותה לבבית.

ב. חוסמי סידן מהווים חלק הכרחי בטיפול במטופלים עם אי ספיקת לב.

ג. מומלץ להוסיף טיפול בחוסם ACE (angiotensin-converting enzyme inhibitor) או ARB (Angiotensin receptor blocker).

ד. שימוש בפוסיד (Furosemide) או זרוקסילין (Metolazone) הכרחי ומשפר פרוגנוזה.

19. אימא של תינוק בן חודש, בריא, מחוסן כפי גילו, ניזון ממטרנה, מגיעה למרפאה מודאגת עקב הממצאים שבתמונה:



מה הטיפול המתאים ביותר לאבחנה הסבירה?

- א. שימון הקרקפת, הורדת הקשקשת ומשחת סטרואידים low potency
- ב. שמפו 2% Ketoconazole 3 פעמים בשבוע לחודש, סירוק עדין
- ג. טיפול מקומי עם Salicylic Acid וקרם סטרואידלי
- ד. החלפת הפורמולה ושמפו תינוקות רגיל

20. ילד בן שנתיים, בריא בדרך כלל. בימים האחרונים היו תלונות המתאימות להתקררות. בלילה האחרון התעורר באמצע הלילה עם שיעול נבחני וצרידות, לאחר שיצאו אתו לאוויר הקר בחוץ, השיעול נרגע וחזר לנשום כרגיל.

מהו הטיפול המתאים ביותר?

- א. שימוש במכשיר אדים קרים בחדר
- ב. מתן תכשיר סטרואידלי פומי
- ג. מתן כיסוי אנטיביוטי ב- Moxypen (amoxicillin)
- ד. מתן חמצן עד לשיפור התסמינים

21. בת 14 באה בליווי אמה. האם מודאגת שבתקופה האחרונה היא לא קמה לבית הספר בבוקר והישגיה בלימודים ירדו מאד. אתה מתרשם ממתח בין הנערה לאמה ומבקש לשוחח עם הבת ביחידות. הנערה מוכנה לשתף פעולה בשיחה בתנאי שתוכן השיחה יהיה חסוי מפני הוריה. באיזה מקרה יש לשתף את ההורים בתוכן השיחה?
- א. זכותם של ההורים לדעת את תוכן השיחה.
 - ב. כשמדובר בבקשה לשימוש באמצעי מניעה.
 - ג. הנערה שותה אלכוהול לעתים תכופות.
 - ד. הרופא מתרשם שהנערה בדיכאון הדורש טיפול.
22. מבוטח שהיה חבר בקופת חולים א' מעוניין לעבור לקופת חולים ב'. בידיו ביטוח משלים ברובד הרגיל של הקופה. המבוטח סובל ממחלה כרונית משמעותית. מה נכון לגבי הבטוחים המשלימים במעבר בין קופות החולים?
- א. הקופה הקולטת תוכל למנוע הצטרפות לביטוח המשלים של מבוטח חולה.
 - ב. הקופה הקולטת תוכל להחריג מחלות קיימות במעבר לקופה מקופה אחרת.
 - ג. הקופה הקולטת תקבל לאותו רובד מבוטח מקופה קודמת ללא תקופת אכשרה בהתאם למשך הביטוח בקופה הקודמת.
 - ד. הקופה הקולטת תקבל לביטוח משלים אבל תוכל לקבוע תעריף מתאים למבטוחים החולים במחלות כרוניות ולהתאימו על פי גיל ההצטרפות.
23. תרופה חדשה נבדקה במחקר רנדומלי כפול סמיות. נמצא שהסיכון ללקות בהתקף לב היה 10% בקבוצת הטיפול ו 12% בקבוצת הביקורת. Relative risk שחושב הוא 0.83. רווח בר סמך 0.75-0.85 Confidence interval (CI). מה נכון לגבי נתוני המחקר?
- א. רווח בר סמך (CI) צר יחסית, דבר המעיד על מובהקות סטטיסטית גבוהה של המחקר.
 - ב. כנראה שהמדגם במחקר היה קטן, ולכן רווח בר סמך (CI) צר יחסית.
 - ג. התרופה הדגימה relative risk reduction של 2% ו NNT של 50.
 - ד. מדובר במחקר רטרוספקטיבי התערבותי.

24. אישה במנופאזה עברה כריתת רחם עקב שרירנים מדממים לפני שנתיים, סובלת מגלי חום, יובש נרתיקי והפרעות שינה. מבקשת טיפול הורמונלי. באנמנזה אין הוריות נגד לטיפול זה.

מה הטיפול המומלץ ביותר?

א. טיפול יומי המשכי באסטרוגן משולב בפרוגסטרון במינון נמוך.

ב. טיפול יומי המשכי באסטרוגן עם פרוגסטרון ציקלי.

ג. טיפול יומי המשכי באסטרוגן בלבד.

ד. קרם אסטרוגן וגינלי.

25. מי מהמטופלים הבאים, שסובל מהפרעות ראייה, צריך בדיקה דחופה של רופא עיניים?

א. בת 23, בריאה בד"כ, בשבוע האחרון רואה הבזקי אור (flashes) בזמן שיעול.

ב. בן 74, לפני כשנה ניתוח קטרקט, בשבוע האחרון רואה הילה מסביב לאור.

ג. בת 83, מזה כשנה רואה 3 כתמים שחורים בשדה הראייה (floaters).

ד. בת 67, בריאה בד"כ, בשבוע האחרון רואה הילה בצבעי הקשת מסביב לאור.

26. בת 31, בשבועות האחרונים ממצא בולט בשורש כף יד שמאל, אינו כואב. בבדיקתה - נגע בקוטר 2 ס"מ, לא נייד, עובר טרנס-אילומינציה. ראה תמונה:



מה יש להסביר למטופלת לגבי טיפול?

- א. הזרקה מקומית של סטרואידים לתוך הממצא תמנע הישנות.
- ב. שאיבת הנוזל עם מחט יעילה במניעת הישנות.
- ג. הממצא מחייב ניתוח כדי למנוע לחץ על Ulnar nerve.
- ד. ניתן לעקוב ללא טיפול.

27. בן 45, בריא בד"כ. מתלונן על כאבי בטן עליונה מזה כשבוע מלווים בבחילות והקאות, חום 37.8 וצואה בהירה מאד.

בבדיקתו - צהבת קלה בלחמיות, רגישות קלה בבטן ימנית עליונה, כבד נמוש 1 ס"מ מתחת לקשת הצלעות ללא הגדלת טחול. בדיקת שתן בסטיק הדגימה בלירובין +++.

מהי האבחנה המתאימה ביותר ?

א. Viral Gastroenteritis

ב. Gilbert's syndrome

ג. Autoimmune Hemolytic Anemia

ד. Drug induced Liver Injury

28. גבר בן 62, מגיע להתייעץ לגבי כתמים חדשים שהופיעו על גופו. שולל נטילת תרופות חדשות או סמים.



מי מבין הפרטים הבאים יחייב הפנייתו לאנדוסקופיה/ CT בטני?

- א. עודף משקל עם $BMI=35$.
- ב. הופעה מהירה ומפושטת מלווה בכתמים מרובים על פני הגוף.
- ג. המוגלובין מסוכרר 6.7 בשתי בדיקות עוקבות בשלושת החודשים האחרונים.
- ד. הופעה מוגבלת לכפלי העור הגב והצוואר.

29. שיעור העישון במרפאת הרופא כפול מהשיעור הארצי.
מה יכול להסביר את הפער?
א. ילדים רבים בקרב מטופליו.
ב. חסר עדכון של הפסקת עישון ברשומות במרפאה
ג. אוכלוסיית המרפאה בעלת רמה סוציאקונומית גבוהה
ד. עדכון קפדני של עישון ברשומות הארציות
30. בן 3 שנים, בריא בד"כ, התפתחות תקינה. לאחרונה החל ללכת למעון יום. מזה כ- 3 ימים שלשולים מימיים עם דם טרי. חום עד 39 מעלות.
מה האבחנה הסבירה והטיפול הנדרש?
א. Shigellosis, התחלת טיפול אנטיביוטי ב- Azenil (Azithromycin)
ב. Salmonellosis, התחלת טיפול ב- Ciprogis (Ciprofloxacin).
ג. Giardiasis התחלת טיפול אנטיביוטי ב- Flagyl (Metronidazole).
ד. Viral Diarrhea, תמיכת נוזלים לפי הצורך.
31. בת 46, אם ל-3 ילדים. חצי שנה מחזור לא סדיר המלווה בהפרשת פטמות דו"צ. עשתה בירור שהדגים פרולקטין בדם 980 נ"ג/מ"ל, ב-MRI הודגמה אדנומה 8 מ"מ.
מה הטיפול המתאים?
א. טיפול תרופתי ב-Cabergoline (Dostinex)
ב. טיפול ניתוחי לאדנומה
ג. טיפול בקרינה לאזור הסלה תורסיקה
ד. טיפול תרופתי ב-Amitriptylin (Elatrolet)
32. אישה בת 28 מטופלת מזה כשנה עם Cipramil (Citalopram) 20 מ"ג עקב דכאון. כעת נכנסה להריון ובאה להתייעץ לגבי המשך הטיפול. מה נכון ליעץ לה כעת?
א. לאחר הלידה יש להעלות מינון ציפרמיל ב-30% עקב חשש מהחמרה של הדיכאון
ב. יש להמשיך טיפול, אך בשליש הראשון של הריון יש להוריד מינון ציפרמיל ל-10 מ"ג עקב חשש מפגיעה בעובד. במידת הצורך, ניתן בהמשך להעלות מינון
ג. יש להעלות מינון ציפרמיל ל-40-30 מ"ג במהלך ההיריון
ד. מומלץ להפסיק לחלוטין את הטיפול במהלך ההיריון עקב חשש מפגיעה בעובר

33. בן 65, בריא בדרך כלל, ללא עישון בעברו. מציין ירידה במשקל בחודשיים האחרונים ללא דיאטה מכוונת. באנמנזה אין תלונות גופניות נוספות.

מהו השלב הבא בברור?

- א. שקילה והשוואה למשקל הקודם
- ב. בדיקות מעבדה ספירת דם, בדיקת כמיה וסמני סרטן
- ג. ביצוע CT חזה בקרינה נמוכה ובדיקת צואה לדם סמוי
- ד. צילום חזה ובצוע CT בטן ואגן

34. בת 28, בהריון בשבוע 22, סובלת ממיגרנות כ- 3 פעמים בשבוע. מטופלת ע"י Rizatriptan (Rizalt) בזמן ההתקפים עם תגובה טובה. לדבריה תדירות ההתקפים גברה, מעוניינת בטיפול מונע.

ניסיון טיפולים לא פרמקולוגיים נכשל.

מה הטיפול המניעתי המתאים ביותר עבורה?

- א. Topiramate (Topamax)
- ב. Propranolol (Deralin, prolol)
- ג. Ramipril (Tritace)
- ד. Acamol (paracetamol)

35. בן 25 מתלונן על "נפיחות בצוואר" שהופיעה לפני כשבוע במקביל לכאבי גרון, ללא חום סיסטמי. בבדיקתו – בדיקת הלוע תקינה, נמושה בלוטת לימפה צווארית קדמית בקוטר כ-2 ס"מ, רכה, מעט

רגישה, ניידת.

מהי ההמלצה לבירור הממצא בשלב זה?

- א. אין צורך בהמשך בירור ומעקב
- ב. מתן טיפול אנטיביוטי אמפירי וביקורת
- ג. הפניה לבדיקות הדמיה של הצוואר והחזה
- ד. מעקב אחר הממצא בעוד חודש ימים.

36. בת 47, מעשנת 30 סיגריות ביום מזה 20 שנה, ברקע מחלה דו קוטבית. מעשנת את סיגריה הראשונה בבוקר עוד לפני שיוצאת מהמיטה מיד כשמתעוררת. נמנעת מטיסות ארוכות כי חוששת שלא תוכל להימנע מעישון. מעשנת גם כאשר חולה או מצוננת. מעוניינת להתחיל תהליך גמילה מעישון.

מה הטיפול התרופתי המתאים ביותר למטופלת זו?

- א. Bupropion (Zyban)
- ב. Bupropion + Varenicline (Champix)
- ג. Varenicline + תחליפי ניקוטין
- ד. תחליף ניקוטין מסוג גומי לעיסה במינון נמוך.

37. בן 49, מזה מספר ימים מתלונן על צריבה, דחיפות ותכיפות במתן שתן, ללא חום סיסטמי. ללא הפרשות מאיבר המין. התלונות לראשונה בחייו. שולל מגע מיני מחוץ לנישואים. ללא ממצא בבדיקה הגופנית. נלקחו שתן לכללית ותרבית. מה הטיפול המתאים ביותר לחולה זה?

- א. מתן Fluoroquinolone
- ב. מתן Beta lactam-beta lactamase
- ג. מתן Ceftriaxone ו- Doxycillin
- ד. מתן Nitrofurantoin

38. מהי ההמלצה לגבי טיפול תרופתי תוך ורידי בהפרעות קצב ע"פ הנחיות ACLS?

- א. במצב של ברדיקרדיה עם דופק מתחת ל-40 יש לטפל מיידיית ב-Atropine תוך ורידי.
- ב. בכל טכיקרדיה עם קומפלקס QRS רחב מתן Magnesium Sulfate תוך ורידי מהווה תרופת הבחירה.
- ג. בטכיקרדיה עם קומפלקס QRS צר וקצב סדיר Adenosine תוך ורידי מהווה תרופת הבחירה.
- ד. במקרה של טכיקרדיה חדרית ללא דופק יש לתת כצעד טיפולי ראשון Epinephrine (Adrenaline) תוך ורידי.

39. ילד בן 3 שנים, בריא בדרך כלל. מתלונן על כאבים באוזן ימין, מושך באוזן ובוכה. מצורפת תמונה של הבדיקה האוטוסקופית:



מהו הסיפור הקליני המתאים לממצא זה?

- א. לאחרונה חזרו מטיסה לארה"ב
- ב. הרבה להתרחץ בבריכה בתקופה האחרונה
- ג. נזלת ושיעול קל בשבועיים האחרונים
- ד. נצפה לאחרונה מנסה לשחק עם קסמי אוזניים